

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

1. ALCANCE.

Esta actividad inicia cuando el personal de epidemiología realiza vigilancia activa y seguimiento de pacientes y termina cuando se analizan las infecciones ante el Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (CODECIAAS).

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Expedientes de paciente.
- Bitácora de bacteriología
- Estudio de caso.
- Lapicera.

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Auxiliar de epidemiología	Se realiza vigilancia activa (IT-UV-17) con el fin de detectar signos y síntomas que se atribuyen a infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS).
5.2		Se revisa diariamente la bitácora de bacteriología. <i>Nota: en caso de detectar crecimiento en los cultivos y hemocultivos de los pacientes, se procede a analizar el caso.</i>
5.3		Se revisa el expediente completo del paciente, con el fin de definir si la infección corresponde a una (IAAS) o no. <i>Nota: para considerarse IAAS, las infecciones deben ser contraídas por un paciente durante su tratamiento</i>

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

		en un hospital, es decir que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. <u>Deben pasar 48 a 72 horas de ingreso al hospital para que se manifieste una infección hospitalaria.</u>
5.4		Se llena "Formato de Estudio de caso de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)" la cual reporta a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).
5.5	Jefe de epidemiología	Revisa y aprueba el estudio de caso.
5.6	Auxiliar de epidemiología	Notifica a Región Sanitaria XIII el estudio de caso a través del correo silvia.medina@jalisco.gob.mx y se notifica en Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica (suive). IT-UV-16
5.7		Se captura en base de datos.
5.8	Jefe de epidemiología	De manera mensual realiza análisis de las infecciones detectadas y trimestral se presenta ante el Comité de Prevención y Control de Infecciones (CODECIN).
5.9	CODECIAAS	Los miembros del Comité realizan análisis de la situación y se comprometen a mejorar los procesos.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Reporte tardío de cultivos de pacientes, por parte de laboratorio clínico.	a. Monitoreo diario y comunicación continua con la jefatura de laboratorio.
b. Retraso en la actualización de notas evolución.	b. Comunicación con dirección médica para resolución del problema.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

c. Omisión de procesos clínicos y no clínicos hacia el paciente.	c. Supervisión constante del personal involucrado en la atención del paciente.
--	--

5. ANEXOS.

									
Estudio Epidemiológico de Caso para la Vigilancia Epidemiológica de las IAAS									
Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE)						FECHA:		DE / DE / DE	
FOLIO RHOVE:				UNIDAD NOTIFICANTE:					
NO. DE EXPEDIENTE:				CLUES:					
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE									
NOMBRE:		Apellido Pátero		Apellido materno		Nombre (s)			
FECHA DE NACIMIENTO:				ENTIDAD DE NACIMIENTO:					
EDAD:				SEXO:		HOMBRE		MUJER	
CURP:									
ESCOLARIDAD:				OCUPACIÓN:					
MIGRANTE		PAIS DE NACIONALIDAD		¿SE RECONOCE COMO INDÍGENA?		SI		NO	
SI		NO		PAIS DE ORIGEN		¿HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA?		SI NO	
PAISES EN TRÁNSITO:		1		2		3		4	
¿HA VIAJADO A OTRO PAÍS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 MESES?		SI		NO		¿EN QUÉ PAÍS ESTUVO HOSPITALIZADO?			
¿DURANTE SU TRÁNSITO ESTUVO HOSPITALIZADO?		SI		NO					
DATOS DE HOSPITALIZACIÓN Y EGRESO									
TIPO DE INGRESO		SERVICIO (donde adquirió la IAAS)		TIPO DE SERVICIO		HOSPITALIZACIÓN		AMBULATORIO	
PRIMERA VEZ				DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE INGRESO					
REINGRESO		CAMA							
FECHAS		DD/MM/AAAA		MOTIVO DE EGRESO		FECHA DE DEFUNCIÓN			
DE INGRESO HOSPITALARIO				PERDIDA DE VIGENCIA		FOLIO DEL CERTIFICADO DE DEF.			
DE INGRESO AL SERVICIO (donde adquirió la IAAS)				MEJORA					
DE INICIO DE SÍNTOMAS DE LA IAAS				ALTA VOLUNTARIA		CAUSA DE MUERTE			
DE DETECCIÓN DE LA IAAS				REFERENCIA A OTRO HOSPITAL		POR IAAS			
DE RESOLUCIÓN DE LA IAAS				DEFUNCIÓN		CON IAAS			
DE EGRESO HOSPITALARIO				ABANDONO NO AUTORIZADO		POR OTRA CAUSA			
ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS									
APP		SI		NO		APP		SI NO	
PREMATUREZ						DESNUTRICION			
BAJO PESO AL NACER						ENFERMEDAD RENAL CRONICA			
DIABETES MELLITUS						EPOC			
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA						VIH/SIDA			
SOBREPESO/OBESIDAD						INMUNOSUPRESIÓN			
TABAQUISMO						CANCER			
OTRO ¿CUAL?									
DATOS DE LA IAAS Y SUS FACTORES DE RIESGO									
TIPO DE IAAS:		Def. clínicamente		¿EL CASO ES PARTE DE UN BROTE?		FOLIO NOTINMED			
		Confirmada por lab.		SI NO					
CIRUGÍAS (relacionadas con la IAAS)									
FECHA DE LA CIRUGÍA DD/MM/AAAA		TIPO (electiva o urgencia)		GRADO DE CONTAMINACIÓN		PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO (CIE-5)		¿SE COLOCÓ UNA PRÓTESIS? (SI/NO)	
FACTOR DE RIESGO NO CONTABILIZABLE (De acuerdo al orden de importancia)		FECHA DE OCURRENCIA DEL EVENTO DD/MM/AAAA		FACTOR DE RIESGO CONTABILIZABLE (De acuerdo al orden de importancia)		FECHA DE INSTALACIÓN DD/MM/AAAA		FECHA DE RETIRO DD/MM/AAAA	

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO														
¿SE TOMÓ MUESTRA PARA DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO?						SÍ		NO		FECHA DE TOMA				
TIPO DE MUESTRA				LABORATORIO				FECHA DE RESULTADO						
RESULTADO		CON DESARROLLO/ POSITIVO				TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO								
		SIN DESARROLLO/ NEGATIVO				MICROORGANISMO AISLADO								
		RECHAZADA												
Hemocultivos solo para ITS	SANGRE PERIFÉRICA		SÍ		NO	¿SE REALIZÓ PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA?				SÍ		NO		
	SANG. POR CATETER CENTRAL		SÍ		NO	TÉCNICA PARA SUSCEPTIBILIDAD								
	PUNTA DE CATETER CENTRAL		SÍ		NO									
Selecciones con una "X" S= Susceptible, I= Intermedio, R= Resistente, ND= No determinada, *CMI= Se refiere a la concentración mínima inhibitoria														
ANTIMICROBIANO		S	I	R	ND	*CMI	ANTIMICROBIANO		S	I	R	ND	*CMI	
AMIKACINA							ERTAPENEM							
AMPICILINA							FLUCONAZOL							
AMPICILINA-SULBACTAM							FOSFOMICINA							
ANFOTERICINA B							GENTAMICINA							
ANIDULAFUNGINA							IMIPENEM							
AZTREONAM							ITRACONAZOL							
CASPOFUNGINA							LEVOFLOXACINO							
CEFAZOLINA							LINEZOLID							
CEFEPIME							MEROPENEM							
CEFOTAXIMA							MICA FUNGINA							
CEFOTETAN							NITROFURANTOINA							
CEFOXITINA							OXACILINA							
CEFTAROLINA							PENICILINA							
CEFTAZIDIMA							PIPERACILINA-TAZOBACTAM							
CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM							POSACONAZOL							
CEFTOZOLANE-TAZOBACTAM							RIFAMPICINA							
CEFTRIAXONA							TETRACICLINA							
CIPROFLOXACINO							TIGECICLINA							
CLINDAMICINA							TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL							
COLISTINA							VANCOMICINA							
DAPTOMICINA							VORICONAZOL							
ERITROMICINA														
¿SE REALIZÓ PRUEBA COMPLEMENTARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA?										SÍ		NO		
¿Existe infección polimicrobiana?				SÍ		NO		MICROORGANISMO AISLADO 2						
TRATAMIENTO (instaurado para la IAAS)														
ANTIMICROBIANO						FECHA DE INICIO				FECHA DE TÉRMINO				DÍAS
DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA IAAS (x)														
MÉDICO TRATANTE		MÉDICO DE LA UVEH		LABORATORIO		CLÍNICA DE HERIDAS		HEMODIALISIS						
ENFERMERIA		ENFERMERIA UVEH		INHALOTERAPIA		CLÍNICA DE CATETER		OTRO ¿CUAL?						
RESPONSABLE DE LA DETECCIÓN				RESPONSABLE DE LA CAPTURA				RESPONSABLE DE LA UVEH						
¿LA IAAS FUE ADQUIRIDA EN OTRA UNIDAD DE ATENCIÓN?						SÍ		NO						
NOMBRE DE LA UNIDAD DE DONDE PROVIENE LA IAAS														
ESTADO DE DONDE PROVIENE LA IAAS														

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

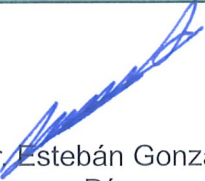
5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales	NA
Formato de estudio de caso de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)	NA
Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica (SUIVE).	IT-UV-16
Vigilancia epidemiológica activa	IT-UV-17
Seguimiento de pacientes hospitalizados	IT-UV-21

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	23/12/2021	Alta de documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	07/11/2023	Modificación del documento	Lic. Viridiana López Fajardo	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
03	30/09/2025	Actualización de instrucción	Lic. Viridiana López Fajardo	Dr. Estebán González Díaz

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)	Jefatura de Calidad	Dirección General

